0.8%セルスクリーン J-Alba を用いた不規則抗体検査の比較検討

◎永田 直輝[1)]、畔地 里佳[1)]、三枝 泰志[1)]、山森 理絵[1)]、竹川 幸身[1)]、樋口 昌哉[1)]、山口 桂[1)]、窪田 裕樹[1)]
JA 愛知厚生連 海南病院[1)]

【はじめに】

当院の不規則抗体スクリーニング検査(以下 SCR)は、バイオビュースクリーンJ(以下BVSJ)を用いてカラム凝集法で実施している。低イオン強度溶液(以下 LISS)を反応増強剤として用いた間接抗グロブリン法(以下 LISS-IAT)とフィシンを用いた酵素 2 段法の二法を採用している。しかし、酵素法は非特異反応の多さや一部の臨床的意義のある抗体を検出できないなどの理由から赤血球型検査ガイドライン改訂 5 版では SCR で実施する意義は低いとされている。今回、業務効率化およびコスト削減を目的に、高感度で酵素法を必要としない 0. 8%セルスクリーン J-Alba(以下 CSJ)の SCR における有用性を比較、検討したので報告する。

【対象･方法】

機器は Ortho Vision を使用し、計 36 件を対象に CSJ による SCR を実施した。内訳は、現行の BVSJ にて①LISS-IAT のみ陽性:2 件、②酵素法のみ陽性:26 件、③両方ともに陽性:1 件、④過去に抗体保有歴あり(現在陰性):1 件、⑤陰性検体：6 件である。追加検査は BVSJ 未処理血球を用いて試験管法にて PEG-IAT 及びブロメリン 1 段法を実施した。

【結果】

BVSJ と CSJ の判定一致率は、①100％(2/2)、③100％(1/1)、④100％(1/1)、⑤100％(6/6)であった。②酵素法のみ陽性であった 26 件との一致率は 11. 5％(3/26)にとどまり、残り 23 件は CSJ で陰性となった。追加検査の結果、23 件は非特異反応であることが示唆された。しかし、②の中で酵素法及び PEG-IAT で抗 E 抗体を認めた 1 件にて、CSJ では陰性を示す結果となった。

【考察】

CSJ は BVSJ と同等の検出感度を有し、BVSJ の酵素法で多発していた非特異反応を軽減できるため、業務効率化への高い有用性が期待された。しかし、酵素法及び PEG-IAT で陽性を呈する抗 E 抗体が CSJ で検出されない症例を 1 件認めた。抗 E 抗体は臨床的意義が高いため、CSJ の使用については十分留意する必要があると考える。

連絡先:0567-65-2511(内線:6350)